

TEMA 4.1 • DERMATOLOGÍA

Generalidades de Dermatología

PERFIL EUNACOM 7.01.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Generalidades de Dermatología

El enfoque diagnóstico en dermatología es **eminente clínico visual e inspeccional**. Rara vez se hace indispensable una biopsia de entrada (con la radical salvedad de la oncología o duda diagnóstica intratable).

- El mapeo de la piel se realiza bajo dos conceptos fundamentales que orientan de inmediato el presunto diagnóstico:
- **Tipo de lesión elemental (La morfología).**
- **Ubicación anatómica de la lesión.**
- (Y en segundo término, los síntomas concomitantes, grupo etario y antecedentes epidemiológicos).

Lesiones Elementales Dermatológicas: Identificación Clásica

• **Mácula**

- - **Definición:** Alteración y cambio de coloración de la piel plana **SIN ningún tipo de relieve**, textura ni hundimiento. Es inmanejable a la palpación. (Sinónimo de "mancha").
- - **Ejemplos clásicos:** *Vitiligo* (máculas hipopigmentadas acrómicas blancas puras), *Melasma/Cloasma* (máculas hiperpigmentadas oscuras en región malar/facial), *Nevus flammeus* (mancha rojo vinoso).

• **Pápula**

- - **Definición:** Lesión cutánea **solevantada, sólida y de pequeño tamaño** (< 1 cm habitualmente).
- - **Ejemplos clásicos:** *Liquen Plano* (Pápulas violáceas pruriginosas en muñecas o tobillos), *Molusco Contagioso* (Pápulas perladas umbilicadas brillantes víricas).

• **Placa**

- - **Definición:** Lesión sólida y **solevantada pero de gran tamaño** (en meseta), formadas típicamente por una confluencia aglomerada de diversas pápulas o extensión continua en superficie mayor a 1 cm.
- - **Ejemplos clásicos:** *Psoriasis* (Gran Placa eritemato-descamativa en codos/rodillas). *Liquen simple crónico / Neurodermatitis* (Gran Placa extremadamente engrosada o liquenificada, clásica en nuca frotada crónicamente).

• **Vesícula**

- - **Definición:** Lesión ampolífera pequeña y solevantada **rellena íntegramente de líquido transparente/seroso** focalizado en dermis o epidermis (< 1 cm).
- - **Ejemplos clásicos:** *Herpes Simple* o *Herpes Zóster* (Grupo de vesículas "en racimo" sobre base roja), *Disidrosis / Pomfólix* (Vesículas agrupadas tensas en caras laterales de los dedos y palmas).

• **Ampolla o Bula**

- - **Definición:** Vesícula inmensa. Colección líquida que supera el 1 cm de tamaño.
- - **Ejemplos clásicos:** Patologías bulosas autoinmunes como el clásico *Pénfigo Vulgar* o el *Penfigoide Bulloso* (Ampollas gigantes e incluso destechadas en mucosas y torso).

• **Pústula**

- - **Definición:** Lesión solevantada del tipo cavidad superficial (similar a vesícula) pero cuyo envoltorio **contiene explícitamente líquido purulento / pus denso blancoamarillento** en su interior de origen microbiano o inflamatorio aséptico puro.
- - **Ejemplos clásicos:** *Acné Pustuloso*, *Foliculitis por Staph. aureus* (pústulas asociadas intrínsecamente a un vello central perforando).

• **Pseudopápulas (Ronchas / Habones)**

- - **Definición:** Elevación rosada circunscrita. Su característica patognomónica es que su matriz proviene de un **Edema Vasomotriz vascular transitorio** local de cortísima duración y que, al deprimir con el dedo en compresión, desaparece totalmente (palidece/se borra). La formación gigante asimila un "Habón".
- - **Ejemplo clínico:** Patognomónico de la alérgica *Urticaria*.
- **Nódulo**
- - **Definición:** Aumento de volumen compacto dérmico y profundo más indurado y palpable en el espacio tridimensional de la hipodermis. Muchas veces son "más palpables que visibles".
- - **Ejemplo clínico:** *Eritema Nodoso* (Duros e inmensamente dolorosos, característicos en la cara anterior pretibial de las piernas).
- **Tumor**
- - **Definición:** De origen tisular celular neoplásico o aberrante hiperplásico progresivo que crece masivo e independientemente en tres ejes como formación "exofítica" o endofítica indurada crónica, perdiendo las características estáticas de una sencilla lesión inflamatoria (ej. *Cáncer Basocelular*).
- **Úlcera**
- - **Definición:** Destrucción y **pérdida focal franca de la continuidad cutánea basal** epitelial en abismo.
- - **Ejemplo clínico:** Mal perforante plantar o *Pioderma Gangrenoso* masivo.
- **Comedones**
- - **Definición:** Tapón del estrato celular incrustado en los infundíbulos de las glándulas sebáceas retorcidas formador de grasa sólida cutánea.
- - **Características:** El cerrado exhibe un punto claro retentor. El abierto manifiesta los desechos epiteliales "oxidados" y denigrados luciendo como el punto "negro" asfixiado común. Lesiones bases del *Acné retencional vulgaris*.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál de las siguientes lesiones cutáneas desaparece al aplicar presión digital sobre ella?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Generalidades de Dermatología. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La mácula es una lesión plana con cambio de color, sin relieve palpable en la piel.
- La pápula es una lesión sobreelevada menor a un centímetro de diámetro.
- La placa es una lesión sobreelevada mayor a un centímetro, típica de la psoriasis.
- Las vesículas contienen líquido transparente y las bulas son versiones más grandes de estas.
- La pústula contiene pus y es la lesión elemental de infecciones y acné inflamatorio.
- La roncha o pseudopápula desaparece con la compresión digital y es propia de la urticaria.
- El comedón abierto o cerrado es la lesión elemental característica del acné.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (GENERALIDADES DE DERMATOLOGÍA)

PREGUNTA 1

¿Cuál de las siguientes lesiones cutáneas desaparece al aplicar presión digital sobre ella?

- A) La pápula eritematosa
- B) La vesícula con contenido transparente
- C) La roncha o pseudopápula urticariana
- D) El nódulo dérmico profundo
- E) La úlcera con pérdida de sustancia

PREGUNTA 2

¿Qué término describe correctamente una lesión cutánea sobreelevada mayor a un centímetro?

- A) Pápula
- B) Vesícula
- C) Mácula
- D) Placa
- E) Comedón

PREGUNTA 3

¿Cuál es la lesión elemental característica del acné?

- A) La vesícula con contenido seroso
- B) El comedón abierto o cerrado
- C) La roncha urticariana transitoria
- D) La mácula hiperpigmentada
- E) La bula o ampolla tensa

RESUMEN: GENERALIDADES DE DERMATOLOGÍA

La dermatología utiliza un lenguaje preciso para describir las lesiones cutáneas. Las lesiones elementales se dividen en no sobreelevadas y sobreelevadas. La mácula o mancha es una lesión plana de color diferente a la piel normal. La pápula es una lesión sobreelevada pequeña, menor a un centímetro. La placa es una lesión sobreelevada grande, mayor a un centímetro. Las vesículas contienen líquido transparente y son pequeñas, mientras que las bulas o ampollas son lesiones con líquido de mayor tamaño. La pústula contiene pus. La roncha o pseudopápula es un edema dérmico transitorio que desaparece a la compresión, característico de la urticaria. El nódulo es una lesión profunda sobreelevada firme. El tumor es una lesión de gran tamaño. La úlcera representa una pérdida de sustancia. El comedón puede ser abierto o cerrado, siendo la lesión elemental del acné. Identificar correctamente cada tipo de lesión es fundamental para llegar al diagnóstico dermatológico correcto y orientar el tratamiento adecuado.